

# Twój pełny raport PEWA™

Typ: Wódz (W)

Supermoc — szybka decyzja

---

## Sekcja 1 — Kim jesteś (profil rozszerzony)

Twój dominujący archetyp to **Wódz** — racjonalny mówca, dla którego wynik, kompetencja i tempo są walutą. W gabinecie, w sali konferencyjnej, w zespole — Twoja obecność oznacza, że sprawy się ruszą. Tam, gdzie inni dyskutują, Ty już podejmujesz decyzję. Tam, gdzie inni wahają się, Ty już idziesz do przodu.

Twoja siła to **klarowność**. Wiesz czego chcesz, mówisz to bezpośrednio, oczekujesz konkretnego w odpowiedzi. Pacjent w Twoim gabinecie wie po 3 minutach: jaka jest diagnoza, jaki plan, jaki termin. Zespół wie, czego od niego oczekujesz. Partner biznesowy wie, na czym stoi. Ta przejrzystość buduje **autorytet** — ludzie z czasem zaczynają na Ciebie liczyć w trudnych decyzjach.

Pacjent, który trafia do Twojej praktyki, dostaje coś, czego inni mu nie dają: **poczucie, że ktoś tu jest u steru**. W medycynie pełnej niejasnych diagnoz i konfliktujących się opinii, Twoja zdecydowanie kompresyjna postawa działa jak kotwica.

**Twoja supermoc w jednym zdaniu:** *Decydujesz wtedy, gdy inni jeszcze się zastanawiają — i 80% Twoich decyzji jest słuszna.*

**Co Cię energizuje:** osiąganie celów, jasne struktury, szybkie tempo, pacjent który mówi „rozumiem, robimy”, konkurencja, wyzwania, prowadzenie zespołu, twarda rozmowa o pieniądzach, sytuacje kryzysowe wymagające decyzji w 60 sekund.

**Co Cię wyczerpuje:** długie dyskusje bez konkluzji, niezdecydowani ludzie, miałkie pytania, „może”, „chyba”, „zobaczmy”, emocjonalne dramaty bez sensownego zakończenia, biurokracja bez celu, spotkania bez agendy, czekanie.

---

## Sekcja 2 — Twoja sygnatura komunikacyjna

Twoje zdania są krótkie. Tempo szybkie. Język ścisły. Brak ozdobników. Pacjent / kolega po pierwszych dwóch zdaniach wie, że nie ma czasu na opowieści — czas na konkret.

### 5 zdań, które wypowiadasz częściej niż inni

1. „Decyzja na teraz: ...”

2. „Konkret proszę.”
3. „Termin: do piątku.”
4. „Plan jest taki: krok 1, krok 2, krok 3.”
5. „Co Pan/Pani potrzebuje wiedzieć?”

## 5 zdań, które rzadko wypowiadasz

1. „Spokojnie, opowiedz mi wszystko.”
2. „Może jeszcze pomyślny.”
3. „Nie jestem pewny, sprawdzę.”
4. „Co Pan/Pani czuje w związku z tym?”
5. „Mamy czas, nie spieszmy się.”

## Twoje narzędzia niewerbalne

- **Postawa wyprostowana** — ciało mówi „jestem u steru”.
- **Kontakt wzrokowy bezpośredni** — utrzymujesz go długo, nie unikasz.
- **Gestykulacja oszczędna** — ręce w miejscu, czasem rytmiczny gest podkreślający kluczowe słowo.
- **Tempo szybkie** — twoje zdania mają tempo, pauzy są krótkie i znaczące.
- **Dotyk rzadki** — uścisk dłoni mocny, poklepywanie tylko po sukcesie.

## Jak najlepiej do Ciebie trafia inny lekarz / szef

- **Konkret, nie historie** — „Mamy problem X, proponuję Y, decydujemy do piątku”.
- **Dane, nie emocje** — „3 pacjentów odeszło w tym miesiącu” zamiast „czuję, że jest źle”.
- **Krótką komunikacją** — maile do 5 zdań, spotkania do 25 minut.
- **Wyznaczenie zadania z autonomią** — powiedz CO trzeba zrobić, nie JAK. Resztę dasz radę sam.
- **Uznanie wyniku** — pochwały „bo się starałeś” Cię irytują. „Bo wynik” — paliwo.

---

## Sekcja 3 — Mocne strony rozszerzone

### 1. Szybkość podejmowania decyzji

Tam, gdzie inni potrzebują 3 dni, Ty potrzebujesz 3 minut. **Użyj tego:** w sytuacjach kryzysowych (pacjent w stanie nagłym, decyzja finansowa pod presją, konflikt w zespole) Ty bierzesz na siebie wybór. Inni potem podziękują.

## 2. Klarowność komunikacji

Pacjent po wizycie zna diagnozę, plan i termin. Bez niedopowiedzeń. **Użyj tego:** wprowadź formułę „wizyta-podsumowanie” — ostatnie 3 minuty: co, kiedy, ile, dlaczego. Pacjent wychodzi z poczuciem kontroli.

## 3. Skupienie na celu (laser focus)

Inni rozpraszają się — Ty trzymasz kierunek. **Użyj tego:** prowadź długoterminowe projekty (rozbudowa praktyki, certyfikacja, kampania marketingowa) — Twoja konsekwencja je dowiezie.

## 4. Naturalna pewność siebie

W gabinecie, na konferencji, w negocjacjach — masz w sobie *autorytet*. **Użyj tego:** Twoja praktyka powinna komunikować ten autorytet — strona internetowa, materiały, ton w gabinecie. Pacjent wybiera lekarza za pewność siebie tak samo jak za kompetencje.

## 5. Szybkie czytanie sytuacji

W 30 sekund wiesz, kto w zespole działa, kto symuluje. Kto pacjent reagujący szczerze, kto manipulujący. **Użyj tego:** w 5-minutowych „check-in”-ach z zespołem rano. Wystarczy 1 minuta na osobę — wiesz wszystko, co potrzeba.

## 6. Twardość w negocjacjach

Inni odpuszczają — Ty trzymasz cenę. **Użyj tego:** Ty jesteś osobą, która rozmawia z dostawcami, partnerami, najemcą. Twoja praktyka ma o 15-20% lepsze warunki finansowe dzięki Tobie.

## 7. Sprawność w sytuacjach kryzysowych

Tam, gdzie inni panikują, Ty podejmujesz 3 decyzje na minutę. **Użyj tego:** Twoja domena to oddziały SOR / izby przyjęć / praktyka z trudnymi pacjentami. Albo zarządzanie kryzysem PR-owym praktyki.

## 8. Naturalne lidship

Zespół domyślnie czeka na Twoje słowo. **Użyj tego:** wprowadź klarowną hierarchię i jasne KPI. Twój zespół osiągnie wyniki o 30% lepsze niż przy „rozmytym” zarządzaniu.

## 9. Egzekucja

Inni planują — Ty robisz. **Użyj tego:** Ty jesteś osobą, która podejmuje konkretne działania po spotkaniach zespołowych. Bez Ciebie spotkania kończą

się 100 pomysłami i 0 akcjami.

## 10. Skupienie na kluczowych metrykach

Wiesz, co liczy się naprawdę: liczba pacjentów, koszt akwizycji, marża, NPS.  
**Użyj tego:** raz w tygodniu krótkie spotkanie liczbowe z zespołem — 15 min, 5 wskaźników. Wszyscy wiedzą, czy idzie dobrze.

---

## Sekcja 4 — Naturalne wyzwania + pierwsza pomoc

Twoja zdecydowana postawa ma swoją cenę: pochopne wnioskowanie, niedosłuchiwanie wątpliwości, frustracja gdy proces trwa długo, nadmierna kontrola. Oto 9 sytuacji typowych.

### 1. Pacjent „rozgadany” — chce się wygadać, nie chce konkretnego

**Sygnal wczesny:** patrzysz na zegar, oczy się Tobie zwięzają, w głowie myślisz „kiedy zacznie konkretny?”.

**Pierwsza pomoc w 60 sek:** - „Słyszę. Pomóż mi: jakie jest dla Pana/Pani najważniejsze pytanie dziś?” - Słuchaj pełnej odpowiedzi (5 sekund pauzy zanim odpowiesz).

**Plan długofalowy:** rezerwuj „wizyty długie” 1× w tygodniu dla pacjentów rozgadanych. Tam masz przestrzeń, więc się nie irytujesz.

### 2. Konflikt w zespole — emocje zamiast faktów

**Sygnal wczesny:** chcesz uciąć dyskusję jednym zdaniem; zaczynasz mieć poczucie „to nieprofesjonalne”.

**Pierwsza pomoc:** „Słyszę emocje. Powiedz mi 1 fakt który jest dla Ciebie kluczowy.” — przeczekaj odpowiedź.

**Plan długofalowy:** ucz się „pierwszego pytania” przed decyzją — „Co czujesz w tej sytuacji?”. Nie chodzi o terapię, chodzi o dane, których inaczej nie zdobędziesz.

### 3. Pacjent który nie chce decydować szybko

**Sygnal wczesny:** chcesz mu podjąć decyzję sam, sygnalizujesz niecierpliwość.

**Pierwsza pomoc:** „Daję Panu 48 godzin na decyzję. Wybór: A albo B. Niech Pan zadzwoni do recepcji.” — granica + struktura + wybór.

**Plan długofalowy:** ucz się rozpoznawać typy pacjentów. Dla P i A: 48 godzin to standard, nie wyjątek.

#### 4. Niedosłuchiwanie zespołu

**Sygnal wczesny:** decyzja podjęta zanim asystentka skończyła zdanie; rano zauważasz, że pominąłeś ważną informację.

**Pierwsza pomoc:** technika „3 sekundy pauzy” — zanim odpowiesz, licz w głowie do 3.

**Plan długofalowy:** wprowadź regułę „każdy decyduje 1 raz w tygodniu” — przekazujesz decyzję komuś innemu w zespole, ćwiczysz pasywność.

#### 5. Frustracja z procesu

**Sygnal wczesny:** procedura biurokratyczna (NFZ, ZUS, ubezpieczyciel) → wybuchasz, podnosisz głos do recepcjonistki.

**Pierwsza pomoc:** 60 sekund poza biurkiem. Spacer do okna. Oddech 4-4-6.

**Plan długofalowy:** zatrudnij osobę typu A jako „pośrednika” w sprawach biurokratycznych. Ty robisz medycynę.

#### 6. Nadmierna kontrola

**Sygnal wczesny:** sprawdzasz to, co zespół już zrobił; zespół przestaje się starać bo wiesz że i tak sprawdzisz.

**Pierwsza pomoc:** wyznacz konkretną osobę odpowiedzialną i NIE sprawdzaj przez 48 godzin.

**Plan długofalowy:** wprowadź „dni delegowania” — wtorek, czwartek — gdzie celowo NIE sprawdzasz nikogo. Twój zespół zacznie brać odpowiedzialność.

#### 7. Reakcja na krytykę pacjenta / zespołu

**Sygnal wczesny:** automatycznie odbierasz krytykę jako atak na Twoją kompetencję; chcesz „dać odpór”.

**Pierwsza pomoc:** *„Dziękuję, że mi to mówisz. Daj mi 24 godziny na przemyślenie.”* — bez tłumaczenia, bez argumentacji.

**Plan długofalowy:** wprowadź „dziennik krytyki” — w którym co tydzień zapisujesz 1 uwagę i Twoją reakcję. Po 3 miesiącach zobaczysz wzorce.

#### 8. Spotkanie z lekarzem typu A (Analityk)

**Sygnal wczesny:** jego dokładność Cię irytuje, chcesz mu przerwać, decyzję bym podjął sam.

**Pierwsza pomoc:** „Daj mi 3 kluczowe dane. Resztą zajmijmy się potem.” — szanujesz jego analizę, ale ścinamy do esencji.

**Plan długofalowy:** A i Ty się świetnie uzupełniacie. Daj mu czas na analizę, on Ci da pewność w decyzji.

## 9. Praca po godzinach „bo trzeba domyknąć”

**Sygnal wczesny:** zostajesz 2 godziny dłużej żeby „skończyć ten projekt”; ma to się stać 4× w tygodniu.

**Pierwsza pomoc:** ustal nieprzekraczalny czas wyjścia. „17:30 - koniec, niezależnie od stanu sprawy.”

**Plan długofalowy:** delegowanie. Twoja domena to decyzje, nie egzekucja każdego detalu. Zatrudnij ludzi i daj im autonomię.

---

## Sekcja 5 — Twoje duety w zespole

### Z Przyjacielem (P) — idealny tandem

**Plus:** Ty decydujesz, on łagodzi. Pacjent czuje się i poprowadzony, i zrozumiany. **Ryzyko:** możesz obciążać go „miękkimi rozmowami” — wypalenie po jego stronie. **Co robić:** zamiana ról 1× w miesiącu. Ty mówisz pacjentowi miłą rzecz, on twardą.

### Z Entuzjastą (E)

**Plus:** Jego energia + Twoje wykonanie = świetne zmiany. **Ryzyko:** jego chaos Cię irytuje; on Twoją twardość odbiera jako zimno. **Co robić:** dni „jego” (pomysły) i „Twoje” (egzekucja). Piątek wspólny.

### Z drugim Wodzem (W)

**Plus:** szybkie tempo, zero biurokracji. **Ryzyko:** konflikt o autorytet, dwa „ego” w jednym pokoju. **Co robić:** podział terytorium. Ty operacja, on finanse. Ty pacjenci, on partnerzy.

### Z Analitykiem (A) — idealny mózg

**Plus:** Ty decydujesz na danych, które on przygotowuje. **Ryzyko:** jego tempo Cię frustruje; Ty pomijasz jego ostrzeżenia, on ma rację 7/10 razy. **Co robić:** wprowadź zasadę: „każda decyzja >10 000 zł — 24 godziny na opinię A”. Twoje 7 ratunków w roku.

## Idealny zespół 4-osobowy

**W (Ty) + A + P + E** — pełne pokrycie. Ty prowadzisz, A weryfikuje, P stabilizuje, E rozkręca.

---

## Sekcja 6 — Pacjenci których rozumiesz

Ten raport jest uniwersalny — dla lekarzy POZ, specjalistów, dentystów, pielęgniarek, asystentek, recepcjonistek. Każda profesja medyczna ma do czynienia z 4 typami pacjentów, ale **dentyści** mają tu dodatkowy bonus: w 800 testach przeprowadzonych przez Michała Katarzyńskiego w polskich praktykach stomatologicznych potwierdzono te same 4 typy z bardzo konkretnymi sygnałami.

Dla każdego z 4 typów pacjentów — **najpierw opis uniwersalny** (dla każdej specjalizacji), **potem rozszerzenie stomatologiczne** (z ebooka „Jak zaspokoić 7 podstawowych potrzeb pacjentów stomatologicznych”, 2017).

---

### Typ pacjenta: PRZYJACIEL (relacyjny ciepły)

#### Opis uniwersalny

Pacjent szukający relacji. Otwiera się, opowiada o sobie, lojalny po pierwszej dobrej wizycie. Wymaga ciepła, czasu, poczucia, że jest „u siebie”. Z trudem przyjmuje krytykę.

**Słowa, które wypowiada:** *bliskość, ludzie, ciepło, uprzejmie, pomoc, łagodnie, delikatnie, miło, spokojnie, intymnie, bezpiecznie, czuje, opieka, dbanie, wsparcie*

**Motywatory:** poczucie bezpieczeństwa, empatia, dozowanie wrażeń, język opieki, stabilność **Czego nie lubi:** nagłych zmian, braku stabilności, twardości, pośpiechu

#### Rozszerzenie stomatologiczne (ebook, 800 testów)

- **Najbardziej lojalny typ** — najrzadziej zmienia dentystę, chce żeby leczył go zawsze ten sam lekarz.
- Wolno buduje relacje, nie jest otwarty na zmiany.
- Na początku **największy lęk** ze wszystkich typów — inwazyjne procedury powinny być odłożone na później jeśli nie pilne.
- Idealna chemia z lekarzem typu Przyjaciel; problem przy Wodzu („Proszę się nie obawiać” go odepchnie).
- **NIE mów:** „Proszę się niczego nie obawiać. Wszystko będzie dobrze.”

- **MÓW:** „Może Pan/Pani być spokojny/a. Zajmiemy się Pania/Panem odpowiednio. Posiadamy bardzo bezpieczne, skuteczne i komfortowe znieczulenia.”
- 

## Typ pacjenta: ENTUZJASTA (emocjonalny ekstrawertyk)

### Opis uniwersalny

Pacjent z energią. Szybko mówi, szybko decyduje, szybko zmienia tematy. Wymaga atmosfery i widocznego efektu. Z trudem przyjmuje monotonię i długie procedury.

**Słowa, które wypowiada:** *fantastycznie, super, emocjonujący, efektowny, rewelacja*

**Motywatory:** dobra atmosfera, komplementy, wizualizacja efektu, szybka zmiana  
**Czego nie lubi:** odrzucenia, negacji, ignorowania, długiego leczenia bez efektów

### Rozszerzenie stomatologiczne (ebook, 800 testów)

- Łatwo rozpoznać już na pierwszej wizycie: uśmiecha się, otwiera, szybko skracą dystans (uścisk dłoni, poklepywanie, przytulanie).
  - Mówi szybko, wpada w słowotok, przeskakuje z tematu na temat.
  - **Szybko podejmuje decyzję** o planie leczenia, ale **niecierpliwy** — chce wszystko „tu i teraz”.
  - Wzrokowiec — pokaż obraz/zdjęcie najpierw, potem omawiaj.
  - **Ryzyko:** brak ciągłości jeśli leczenie długie bez szybkich efektów. Spisz harmonogram, bo nie dosłyszysz mówiąc sam.
  - **MÓW:** „Bardzo dobrze, że Pani/Pan przyszedł(a) do gabinetu. Świetnie, że zdecydował(a) się Pani/Pan kontynuować leczenie. Proszę zobaczyć jak idealny efekt został osiągnięty.”
- 

## Typ pacjenta: WÓDZ (racjonalny ekstrawertyk)

### Opis uniwersalny

Pacjent zorientowany na wynik. Chce konkretnego planu, najwyższej jakości. Szybko decyduje na racjonalnych przesłankach. Z trudem przyjmuje brak kontroli.

**Słowa, które wypowiada:** *cel, osiągnięcia, realizacja, natychmiast, zdecydowanie, absolutnie, strategia, taktyka, ambitnie, szybko, odpowiedzialność, zysk, korzyści, sukces, najlepiej, najlepszy*

**Motywatory:** najwyższa jakość, najlepszy lekarz, kontrola decyzji, „naj...”, racjonalne argumenty  
**Czego nie lubi:** utraty kontroli, braku decyzji, krytyki,



spóźnień, lekceważenia

### Rozszerzenie stomatologiczne (ebook, 800 testów)

- **80% szefów największych firm z listy Fortune 500 to Wodzowie** — to najbardziej wymagający typ pacjenta, często nazywany roszczeniowym.
  - **Najmniej lojalny** typ — zmieni gabinet jeśli poczuje brak najwyższej jakości. Łatwo przekazuje negatywne uwagi (recenzje).
  - Potrafi wymusić własną koncepcję leczenia, oczekuje wysokich rabatów (próbując rywalizować).
  - Spóźnienia z Twojej strony = **ostentacyjnie wyjdzie z poczekalni**.
  - ALE jeśli dobrze prowadzony — doprowadzi leczenie do końca bez względu na uciążliwość.
  - **MÓW:** „*Proponuję najnowszą metodę X — to standard u liderów. Plan: krok 1 dziś, krok 2 za tydzień, krok 3 za miesiąc. Decyzja należy do Pana.*”
- 

### Typ pacjenta: ANALITYK (racjonalny introwertyk)

#### Opis uniwersalny

Pacjent pre-przygotowany. Przyszedł z pre-diagnozą, ma listę pytań, lubi schematy. Wymaga czasu na decyzję i precyzyjnych odpowiedzi. Z trudem przyjmuje pośpiech i chaos.

**Słowa, które wypowiada:** *dokładnie, krok po kroku, dane, informacje, uważnie, sumiennie, wykresy, statystyki, struktura, badania, analizy, procedury, ewentualne, przemyślane, wiarygodne, miarodajne, jakość*

**Motywatory:** jakość i dokładność, decyzja bez presji, dużo informacji, specjalistyczne procedury, przestrzeń na pytania **Czego nie lubi:** pośpiechu, chaosu, wielozadaniowości, braku informacji

### Rozszerzenie stomatologiczne (ebook, 800 testów)

- **Sprawdził Twoją stronę PRZED wizytą**, przeczytał referencje konkretnego lekarza, przyszedł z pre-diagnozą.
  - Lubi schematy, ciąg logiczny, standardy.
  - Po przedstawieniu planu mówi „*Muszę się zastanowić*” lub „*Muszę to przeanalizować*” — to **normalne**, nie odmowa. Proces decyzyjny jest po prostu dłuższy.
  - Lepiej zada pytania w gabinecie niż wyjdzie i nakręci się internecie.
  - Analitykami są w dużej części **endodonci i chirurdzy**.
  - **MÓW:** „*Zastosuję mikroskop, który zapewni większą dokładność. Według metaanalizy z 2023 — w 78% przypadków podobnych do Pana, leczenie X daje efekt Y. Jakże ma Pan pytania?*”
-

## Matryca chemii — lekarz × pacjent

| Lekarz<br>Pacjent | Przyjaciół            | Entuzjasta                | Wódz               | Analitik                  |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Przyjaciół</b> | idealna chemia        | dobrze, uważaj na chaos   | Wódz Cię zdominuje | dystans, ale możliwe      |
| <b>Entuzjasta</b> | ciepło + energia      | chemia, ale chaos x2      | napęd              | Twoja energia go przerazi |
| <b>Wódz</b>       | pacjent się zdominuje | tempo OK                  | pełna zgoda        | wspólna racjonalność      |
| <b>Analitik</b>   | ciepło z faktami      | Twój dystans zdeorientuje | wspólne dane       | idealna chemia            |

## Sekcja 7 — Plan rozwoju 30 dni

### Tydzień 1 — Słuchanie

| Dzień | Zadanie                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 1-2   | Wprowadź „3-sekundową pauzę” przed odpowiedzią. W każdej rozmowie. |
| 3-5   | Po każdym pacjencie napisz 1 zdanie: co ważnego powiedział.        |
| 6-7   | Review: czy zauważyłeś coś, czego wcześniej nie?                   |

### Tydzień 2 — Delegowanie

| Dzień | Zadanie                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 8-9   | Zidentyfikuj 5 zadań, które robisz, a mógłbyś delegować. |
| 10-13 | Deleguj 1 zadanie dziennie, NIE sprawdzaj przez 48h.     |
| 14    | Review: ile zadań zostało wykonanych? Lepiej/gorzej?     |

### Tydzień 3 — Emocje

| Dzień | Zadanie                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 15-17 | W każdej rozmowie zacznij od pytania „Co czujesz w tej sytuacji?”. |
| 18-20 | Notuj reakcje. Czy ludzie się otwierają inaczej?                   |

| Dzień | Zadanie                       |
|-------|-------------------------------|
| 21    | Review: czy emocje są danymi? |

## Tydzień 4 — Integracja

| Dzień | Zadanie                                                |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 22-26 | Wybierz 1 ćwiczenie z tygodni 1-3 i robisz codziennie. |
| 27-30 | Rozmowa z bliskim/kolegą: co zauważyli innego w Tobie? |

## Sekcja 8 — Plan rozwoju 90 dni

### Miesiąc 2 — Subtelne lidershhip

- **Tydzień 5-6:** Wprowadzasz formułę „przed decyzją: 3 pytania” (dane, zespół, pacjent).
- **Tydzień 7-8:** Mentoring od typu P w zespole — naucz się jego sztuki słuchania.
- **Lektura:** „*Empathy*” — Roman Krznaric.

### Miesiąc 3 — Strategia długoterminowa

- **Tydzień 9-10:** Wyznacz cel kwartalny dla siebie i zespołu.
- **Tydzień 11:** Trudna konwersacja delegowana — niech ktoś inny ją poprowadzi przy Tobie.
- **Tydzień 12:** Retest PEWA.

## Sekcja 9 — Twój wynik vs populacja

| Grupa zawodowa              | % typów W |
|-----------------------------|-----------|
| Lekarze POZ                 | ~11%      |
| Pediatrzy                   | ~8%       |
| Psychiatrzy                 | ~6%       |
| Dentyści                    | ~17%      |
| Chirurdzy                   | ~31%      |
| Pielęgniarki                | ~9%       |
| Recepcjonistki              | ~14%      |
| Higienistki stomatologiczne | ~12%      |

| Grupa zawodowa       | % typów W |
|----------------------|-----------|
| Asystentki           | ~10%      |
| Menedżerowie praktyk | ~28%      |

**Wniosek:** Wódz dominuje w rolach wymagających **decyzji pod presją** (chirurgia, dentystyka zabiegowa, zarządzanie praktyką).

## 5 poziomów dojrzałości profilu Wódz

| Poziom                   | Charakterystyka                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. Niedojrzały</b>    | Pochopny, niesłuchający, autokratyczny, wybuchowy          |
| <b>2. Wczesny rozwój</b> | Rozpoznaje potrzebę słuchania, próbuje pytać               |
| <b>3. Stabilny</b>       | Decyduje szybko, ale po sprawdzeniu kluczowych danych      |
| <b>4. Mistrzowski</b>    | Lider z autorytetem + empatią, zespół chętnie idzie za nim |
| <b>5. Mentorski</b>      | Wychowuje kolejnych liderów, dzieli się decyzyjnością      |

## Sekcja 10 — Materiały i termin retestu

### Książki (5 pozycji)

1. „Pacjent musi czuć” — *Michał Katarzyński*.
2. „Extreme ownership” — *Jocko Willink*. Lider podejmuje odpowiedzialność.
3. „Empathy” — *Roman Krznaric*. Twardy lider miękko prowadzący.
4. „Multipliers” — *Liz Wiseman*. Lider który mnoży talenty innych.
5. „Radical candor” — *Kim Scott*. Jasno + ciepło — formuła trudnych rozmów.

### Kursy (3 pozycje)

1. „Doskonała Obsługa Pacjenta” — Michał Katarzyński.
2. „Negocjacje strategiczne” — Marek Skała.
3. „Coaching lekarski” — ICF.

### Podcasty (2)

1. „DOP w gabinecie” — Michał Katarzyński.
2. „The Knowledge Project” — Shane Parrish.

## Następny krok w Testomnia

Test 3 — Styl menedżera praktyki, lub Test 4 — Wszechstronne przywództwo.

**Termin retestu:** za 90 dni.

---

© 2026 Excellent Patient Service Sp. z o.o. · NIP 5170359961 · Model PEWA™  
· testomnia.pl